TEMA 10 · Bioética, Código Deontológico, consentimiento informado y secreto profesional. Calidad en el SNS

Resumen OPE Enfermería SMS · Bloque A: Ética y bioética, Código Deontológico, consentimiento informado, eutanasia y relevancia penal del secreto · Bloque B: Calidad asistencial, EFQM, seguridad del paciente, Proyectos Zero y atención basada en valor

A1. Moral, ética, deontología y derecho

Concepto	Qué es	Sanción
Moral (*mos*: costumbre)	Normas y costumbres **prácticas** de un grupo: ¿qué debo hacer?	Reproche social o remordimiento
Ética (*ethos*: carácter)	Reflexión **filosófica, teórica** sobre la moral: ¿por qué?	Sin sanción externa
Deontología (*déon*: deber)	Deberes de una **profesión**, plasmados en un código	**Colegial / disciplinaria**
Derecho	Normas del Estado, coercitivas	**Judicial** (multa, prisión, inhabilitación)

- **Potter (1970)** acuñó "bioética" ("Bioethics: the science of survival"; "Bridge to the future", 1971).
- Hitos: **Código de Núremberg (1947)**, tras los juicios a los médicos nazis: primer reconocimiento del **consentimiento voluntario** en investigación. **Declaración de Helsinki (1964)**, Asociación Médica Mundial. **Informe Belmont** (EE. UU., tras **Tuskegee**): respeto a las personas, beneficencia y justicia.
- **Beauchamp y Childress (1979)**: 4 principios *prima facie*. **Diego Gracia**: nivel I (**mínimos**: no maleficencia y justicia) por encima del nivel II (**máximos**: autonomía y beneficencia). Truco: "**NO JU**egues con mi **AU**to **BENE**ficio".
- No maleficencia = no dañar (negativo: asepsia, dosis correctas). Beneficencia = hacer el bien (positivo: curar una úlcera, analgesia, EpS).

> **TRAMPAS DE EXAMEN**
>
> ! Moral = **práctica**; ética = **teoría**. Núremberg = médicos nazis; Belmont = Tuskegee.

A2. Código Deontológico y objeción de conciencia

- **Resolución 32/1989** del Consejo General de Enfermería. El manual cita un **nuevo Código Ético y Deontológico** aprobado por la Asamblea del CGE (en vigor hacia **2026**), con telemedicina, redes sociales, voluntades anticipadas, objeción de conciencia y derechos digitales.
- El colegiado incurre en responsabilidad disciplinaria por **comisión, omisión voluntaria o negligencia**.
- Artículos destacados del nuevo código según el manual: **7** (protección integral), **12** (priorizar a los **vulnerables**), **15** (modelo **deliberativo**, prohíbe el paternalismo), **25** (incapacidad de hecho; comprobar las voluntades anticipadas y, si se incumplen, elevarlo al CEA o a la gerencia), **26** (derecho a no saber), **27** (**rechazo al tratamiento**: nunca justifica el abandono ni el alta punitiva), **30-31** (registros y claves personales), **89** (dispositivos digitales: consentimiento del paciente y **autorización de la institución**), **28-29** (secreto también **tras la muerte**).
- **Objeción de conciencia** (art. 16.1 CE): **individual** (nunca colectiva), **anticipada y por escrito**. **No cabe en una urgencia vital** sin otro profesional disponible.

> **TRAMPAS DE EXAMEN**
>
> ! Fotografiar una úlcera con el **móvil personal** no basta con el consentimiento verbal: hace falta autorización institucional y dispositivo corporativo.

A3. Consentimiento informado (Ley 41/2002)

- **Art. 8**: conformidad **libre, voluntaria y consciente**, tras recibir información adecuada. **Regla general: verbal**. **Escrito** ("C.I.R."): **Cirugía**, procedimientos **Invasores** y riesgos de notoria **Repercusión** negativa. **Art. 6**: derecho a la información epidemiológica.
- **Excepciones (art. 9.2)**: **riesgo para la salud pública** (LO 3/1986; si hay internamiento, comunicarlo al juez en **24 horas**) y **riesgo inmediato grave** para el paciente sin posibilidad de autorización.
- **Representación**: incapacidad de hecho (a criterio del médico), incapacidad legal por sentencia o menor sin madurez.

Edad	Quién consiente
< 12 años	Padres o tutores (el menor es escuchado)
12-15 años	Si es **menor maduro**, él; si no, los padres
16-17 años o emancipado	**Mayoría de edad sanitaria**: él
16-17 en grave riesgo, ensayos clínicos, reproducción asistida	**Representante legal**, oída la opinión del menor

- **LO 1/2023** (modifica la ley de salud sexual): las menores de **16 y 17 años** y las mujeres con discapacidad consienten **solas** la **IVE**; se suprime el consentimiento y el conocimiento de los padres y los **3 días de reflexión**.
- **Ley 3/2009 de Murcia**: información en 4 áreas (**AEPS**: asistencial, epidemiológica, planes, sistema sanitario); libre elección de médico, enfermera y centro (arts. 43-47).
- **Instrucciones previas (Decreto 80/2005)**: notario, 3 testigos (2 sin parentesco hasta 2.º grado ni relación patrimonial; la enfermera que le atiende no debe ser testigo) o funcionario del Registro; revocables; prevalece el más reciente.
- **LORE (LO 3/2021, de 24 de marzo)**: nacionalidad o residencia legal o empadronamiento **> 12 meses**; **mayor de edad** y capaz (o con instrucciones previas); enfermedad grave e incurable o padecimiento grave, crónico e imposibilitante; **2 solicitudes por escrito separadas al menos 15 días naturales**. **Registro de objetores** confidencial.

A4. Relevancia penal del secreto profesional

- **Intimidad** (esfera reservada; **art. 18.1 CE**), **privacidad** (entorno físico: cortinas, llamar a la puerta) y **confidencialidad** (garantía de no revelar).

Precepto del Código Penal	Conducta	Pena
Art. 197	Descubrir secretos (apoderarse, interceptar)	—
Art. 197 bis	**Acceso no autorizado** a sistemas (curiosear la historia clínica)	Prisión **6 meses a 2 años**
Art. 197.6	Con **fines lucrativos**	Mitad superior de la pena
Art. 199.1	Trabajador que revela secretos conocidos por su oficio (celador, limpieza)	Prisión **1-3 años**, multa 6-12 meses
Art. 199.2	**Profesional** que incumple su sigilo	Prisión **1-4 años**, multa 12-24 meses, **inhabilitación 2-6 años**

- Otras vías: civil (indemnización), administrativa (separación del servicio) y colegial.
- **Excepciones** (cumplimiento de un deber, **art. 20.7 CP**): mandato judicial (solo lo pedido), riesgo vital para terceros, **EDO** (LO 3/1986), delitos públicos (**art. 262 LECrim**: parte de lesiones) y consentimiento del paciente.
- **Secreto compartido**: lícito entre el equipo asistencial directo en un ámbito reservado; no en pasillos, cafetería o con ajenos al caso.

TRAMPAS DE EXAMEN

! El **mero acceso** sin relación asistencial ya es delito (art. 197 bis), aunque no se cuente a nadie.

BLOQUE B · Calidad en el Sistema Nacional de Salud

B1. Marco y dimensiones de la calidad

- Cronología: **CE art. 43**; **Ley 14/1986** (crea el SNS); **Ley 2/1990** (según el manual, crea el SMS: la **autoridad sanitaria** es la **Consejería** y la **gestión**, el **SMS**); **Ley 16/2003** (calidad sistémica; crea la **Agencia de Calidad del SNS**).
- **Plan de Calidad del SNS**: **6 áreas y 12 estrategias** (protección y promoción con NAOS y AP-21; equidad; recursos humanos; excelencia clínica con GuíaSalud, ENEAS y seguridad; tecnologías de la información; transparencia y Banco de Datos del SNS).
- **Plan de Salud de Murcia 2026-2032**: determinantes, problemas de salud, asistencia sanitaria y planificación basada en datos.

Dimensión	Definición
Científico-técnica	Usar el mejor conocimiento disponible (PBE)
Eficacia	Resultado en condiciones **ideales** (ensayo clínico)
Efectividad	Resultado en la **práctica real**
Eficiencia	Máxima efectividad con el **mínimo coste**
Accesibilidad	Facilidad para obtener la atención (barreras geográficas, organizativas, económicas, culturales)
Equidad	Según la **necesidad** ("dar más a quien más lo necesita"), no lo mismo a todos
Adecuación	Hacer solo lo indicado (evita infra y **sobretratamiento**)
Seguridad	Atención sin daños evitables
Satisfacción / experiencia	Expectativas cumplidas / vivencia de todo el recorrido asistencial

B2. Evaluación y mejora continua

- **Donabedian (1966)**: buena **estructura** → buen **proceso** → buen **resultado**. La estructura se evalúa con inspecciones, licencias y acreditación; el proceso, con **auditoría clínica**; el resultado es lo más difícil de atribuir.
- Mejora continua: los errores son sobre todo fallos del sistema, no de la "manzana podrida".
- **Ciclo PDCA** (Shewhart, popularizado por **Deming**): **Plan** (planificar), **Do** (aplicar, en una **prueba piloto**), **Check** (verificar) y **Act** (estandarizar o corregir y reiniciar).

Concepto	Qué es	Ejemplo
Criterio	La norma cualitativa de buena práctica	"Toda gestante ingresada llevará pulsera de identificación"
Indicador	La fórmula que mide el cumplimiento	(gestantes con pulsera / total ingresadas) × 100
Estándar	La meta numérica aceptable	100%

- Los estándares de seguridad vital o derechos se fijan en el **100%**; otros (dolor controlado), en el **80-90%**.

> **TRAMPAS DE EXAMEN**
>
> ! "El 95% de los pacientes debe tener firmado el consentimiento" es un **estándar**, no un indicador.

B3. EFQM 2020, certificación y seguridad del paciente

- **EFQM 2020** (inspirado en el **círculo dorado de Sinek**): **3 bloques y 7 criterios** (antes 9).

Bloque	Criterios
Dirección (por qué)	1. Propósito, visión y estrategia · 2. Cultura y liderazgo
Ejecución (cómo)	3. Implicar a los grupos de interés · 4. Crear valor sostenible · 5. Gestionar el funcionamiento y la transformación
Resultados (qué)	6. **Percepción** de los grupos de interés (PREMs, clima, burnout) · 7. **Rendimiento** estratégico y operativo (mortalidad, IAAS, estancia)

- Herramienta **REDER** (RADAR): Resultados, Enfoque, Despliegue, Evaluación y Revisión.
- **ISO 9001**: certificación de procesos y documentación (origen industrial). **Joint Commission International**: **acreditación** sanitaria centrada en el paciente y en las metas de seguridad (identificación, comunicación SBAR, medicamentos de alto riesgo, cirugía segura, caídas). **UNE 179003**: gestión de riesgos para la seguridad del paciente.
- **"To Err is Human" (1999)**. **ENEAS**: eventos adversos en torno al **9%** de los ingresados, **más del 42% evitables** (en AP, estudio **APEAS**); causas: medicación, infecciones y cuidados.
- **Estrategia de Seguridad del Paciente del SNS**: cultura de seguridad justa, prácticas seguras, **notificación voluntaria, confidencial, anónima y no punitiva** (**SiNASP**) e implicación del paciente.
- **AMFE** = **proactivo** (antes del fallo, en procesos nuevos). **Análisis causa raíz** = **reactivo** (tras un evento centinela).

Proyectos Zero (paquetes de medidas)

Proyecto	Medidas clave
Bacteriemia Zero (CVC)	Higiene de manos; máximas barreras estériles; **clorhexidina alcohólica > 0,5%** (2%); **preferir subclavia, evitar femoral**; retirar vías innecesarias
Neumonía Zero (NAV)	Cabecero a **30-45°**; higiene bucal con clorhexidina 0,12-0,2%; **neumotaponamiento 20-30 cmH_2O**; no cambiar tubuladuras de rutina; interrupción diaria de la sedación
ITU Zero	Indicación estricta y asepsia; **sistema cerrado**; buena fijación; retirada precoz
Resistencia Zero	Optimizar antibióticos; higiene de manos; precauciones de contacto; descolonización
Flebitis Zero	Menor calibre posible; clorhexidina; apósito transparente; **cambiar el catéter solo por indicación clínica** (no cada 72-96 h)

B4. Atención basada en valor, programas de calidad y PBE

- **Value-Based Healthcare** (**Porter y Teisberg**, Harvard): **Valor = resultados en salud / costes del ciclo completo**. **Unidades de Práctica Integrada** organizadas por condición clínica.
- **PROMs** (resultados de salud que reporta el paciente: dolor, función, calidad de vida; **SF-36, EQ-5D, WOMAC**) frente a **PREMs** (experiencia: trato, esperas, información; **NPS, HCAHPS**). Consorcio **ICHOM**. En España, **IEXPAC** (experiencia del paciente crónico): **11 ítems** + 4 opcionales.
- **Programa de calidad en una unidad**: 1) identificar el problema (**Pareto 80/20**; **Ishikawa** o espina de pescado: métodos, mano de obra, materiales, medio); 2) objetivos **SMART**; 3) diseñar la intervención (procedimientos, vías clínicas); 4) ejecutar, formar y monitorizar.
- **GRADE** (2000): calidad **alta, moderada, baja o muy baja** (símbolos ⊕); ECA parten de alta y observacionales de baja; recomendación **fuerte** (aplicar a casi todos; puede ser indicador obligatorio) o **débil** (decisión compartida).
- **PBE** (McMaster; **Sackett, 1996**): evidencia + experiencia + valores del paciente. 5 A con **PICO** y la **pirámide 6S de Haynes** (empezar por la cúspide: sistemas, sumarios como UpToDate, sinopsis, síntesis, sinopsis de estudios y estudios).

TRAMPAS DE EXAMEN

! El dolor 2/10 tras una prótesis que reporta el paciente es un **PROM**, no un PREM.

! Letras y números (A, 1++) **no** son GRADE.